

ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ

Δράση: Ενισχύουν και επιμηκύνουν τη δράση του γ-αμινοβουτυρικού οξέος GABA (κύριος ανασταλτικός νευροδιαβιβαστής του ΚΝΣ). Έτσι, έχουν κατασταλτική και υπνωτική δράση. Τα από του στόματος βαρβιτουρικά απορροφώνται ταχέως από τον γαστρεντερικό σωλήνα. Τα βαρβιτουρικά συνήθως βρίσκονται σε μορφή λευκής πούδρας ή σε υγρή μορφή. Διακρίνονται σε κατηγορίες, ανάλογα με τη διάρκεια δράσης τους.

- ♦ **Υπερβραχείας δράσης:** Χρησιμοποιούνται στη χειρουργική, κατά τη βασική αναισθησία, και περιλαμβάνουν κυρίως τα θειοβαρβιτουρικά (π.χ. Θειοπεντάλη - *Pentothal*, *Trapanal*).
- ♦ **Βραχείας δράσης (3 ώρες):** Υπναγωγά φάρμακα ή για χρήση στη προαναισθητική αγωγή (Νεμβουτάλη και Σεκονάλη).
- ♦ **Μέσης δράσης (3-6 ώρες):** για τη διατήρηση του ύπνου (Αμοβαρβιτάλη - *Amytal*).
- ♦ **Μακράς δράσης (> 6 ώρες):** π.χ. Φαινοβαρβιτάλη (*Gardenal*), Πριμιδόνη (*Mysoline*).

Κλινική εικόνα: Εκδήλωση δηλητηρίασης αναμένεται σε λήψη εφ' άπαξ δόσης τουλάχιστον 10πλάσιας της υπνωτικής. Η τοξική δόση δεν είναι απολύτως καθορισμένη. Σε ήπια ή μέτρια τοξικότητα ο ασθενής εμφανίζεται με εικόνα που μοιάζει με μέθη· παρουσιάζεται δηλαδή με κεφαλαλγία, ταχυκαρδία, γρήγορη και επιπόλαιη αναπνοή, διανοητική σύγχυση, υπνηλία, ψευδαισθήσεις, τρόμο. Επί σοβαρής τοξικότητας εμφανίζεται κατατονία, βαριά υπόταση ή εικόνα shock (με $MAP < 65 \text{ mmHg}$), βραδυκαρδία, αναπνοή βραδεία και βαθιά, υποθερμία, υπογλυκαιμία, απώλεια αισθήσεων μαζί με αναπνευστική καταστολή ή/και κώμα, θάνατος. Οι κόρες είναι σε μύση, αλλά το μέγεθος και η αντιδραστικότητα τους ενίοτε ποικίλλουν. Το δέρμα είναι κυανωτικό και ψυχρό και μπορεί να εμφανιστούν πομποί μεσοδακτύλια.

Θεραπευτική παρέμβαση

Για την αντιμετώπιση της δηλητηρίασης εφαρμόζεται η λεγόμενη «**Σκανδιναβική μέθοδος**» που στοχεύει στην ανάταξη της υποξίας και του shock και στην αποκάθαρση από την ουσία.

1. Αξιολογούνται αρχικώς τα A-B-C-D-E του ασθενούς (αεραγωγός, αναπνοή, κυκλοφορική υποστήριξη, νευρολογικός έλεγχος). Εφόσον ο ασθενής βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση ($GCS < 8$) διασωληνώνεται κι αναρροφώνται οι εκκρίσεις του τραχειοβρογχικού δένδρου.
2. Χορηγείται O_2 στα 4-8 lt/min, με απλή προσωπίδα οξυγόνου ή μάσκα Venturi (24-31%).
3. Τοποθετείται απαραίτητως 3way φλεβική γραμμή, ει δυνατόν μεγάλου εύρους (#16-18G).
4. Σε ασθενή που βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση ή δεν έχουν παρέλθει περισσότερες από 6-8 ώρες από τη λήψη, τοποθετείται ρινογαστρικός σωλήνας Levin και επιχειρείται προσεκτικά πλύση στομάχου με NaCl 0,9%, μέχρις ότου τα εκπλύματα να είναι διαυγή.
5. Εάν το άτομο διατηρεί τις αισθήσεις του, χορηγείται per os ενεργός άνθρακας (*Toxicarb fl. 250 ml*) ή/και αλατούχα καθαρτικά (3-5 sachets *Molaxole 13,7 gr* ή *Fortrans 74 gr*).
6. Ανυψώνεται η κεφαλή του ασθενούς σε κλίση 30-45° ώστε να μειώσουμε την εγκεφαλική φλεβική πίεση και την πιθανότητα εμφάνισης εγκεφαλικού και πνευμονικού οιδήματος.
7. Σε εμφάνιση κυκλοφορικής καταπληξίας (shock), χορηγούνται κρυσταλλοειδή διαλύματα ή κολλοειδή (διάλυμα *HES*) ή Αλβουμίνη 5%, για τη διατήρηση της ΣΑΠ $\geq 80-90 \text{ mmHg}$.
8. Τοποθετείται 2^η φλεβική γραμμή, με 500 ml NaCl 0,9% και εφόσον η υπόταση επιμένει, χορηγούμε ινóτροπα. Έτσι, διαλύουμε 4-8 amp. (200-400 mg) Ντοπαμίνης (*Giludop*) σε 500-1000 ml NaCl 0,9% και χορηγούμε με ρυθμό 5-10 $\mu\text{g/kg/min}$ (αναλόγως της ΑΠ).
9. Τοποθετείται ουροκαθετήρας Foley (14-16 fr), για μέτρηση των αποβαλλόμενων ούρων, των οποίων ο ρυθμός αποβολής πρέπει να κυμαίνεται στα 4-6 ml/kg/h.
10. Η αλκαλοποίηση των ούρων βοηθά στην απέκκριση των βαρβιτουρικών μακράς δράσης. Έτσι, ειδικά επί οξέωσης, χορηγούμε 100 ml NaHCO_3 , εντός διαστήματος 30-45 λεπτών.
11. Προγραμματίζεται η άμεση διακομιδή του ασθενούς στο νοσοκομείο, συνοδεία ιατρού, υπό συνεχές monitoring (*HKT, HR, ΑΠ, RR και SpO2*), για νοσηλεία σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ.